

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMANTAUAN TERAPI OBAT		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 571.1/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 04	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. PTO dilakukan oleh apoteker penanggungjawab masing-masing ruangan rawat inap dan didokumentasikan di lembar Pemantauan Terapi Obat Rumah Sakit Prima Husada.		
Tujuan	1. Sebagai acuan pemantauan terapi obat. 2. Mengoptimalkan efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi		
Prosedur	1. Tentukan prioritas pasien yang akan dilakukan PTO berdasarkan pada seleksi pasien. a. Kondisi pasien. • Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit dan menerima polifarmasi • Pasien kanker yang menerima terapi sitostatika • Pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal • Pasien geriatri dan pediatri • Pasien hamil dan menyusui • Pasien dengan perawatan intensif b. Pasien yang menerima obat : • Obat dengan indeks terapi sempit • Obat nefrotoksik dan hepatotoksik • Obat sitostatika • Obat antikoagulan • Obat yang sering menimbulkan ROTD • Obat kardiovaskular c. Kompleksitas regimen : Obat dengan cara pemberian khusus, variasi rute pemberian dan variasi aturan pakai. 2. Kumpulkan data pasien, pengumpulan data pasien dapat diperoleh dari : a. Rekam medik b. Pencatatan penggunaan obat c. Wawancara dengan pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lain 3. Lakukan identifikasi masalah terkait obat, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Ada indikasi tetapi tidak di terapi b. Pemberian obat tanpa indikasi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMANTAUAN TERAPI OBAT		
	No. Dokumen 571.1/I-SPO/IFRS/VI/2025	No. Revisi 04	Halaman 2 / 2
	c. Pasien mendapatkan obat yang tidak diperlukan. d. Pemilihan obat yang tidak tepat. e. Pasien mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya (bukan merupakan pilihan pertama, obat yang tidak cost effective, kontra indikasi. f. Dosis terlalu tinggi g. Dosis terlalu rendah h. Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD) i. Interaksi obat j. Pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab 4. Beri rekomendasi penyelesaian terkait obat 5. Lakukan pemantauan dengan parameter sebagai berikut: a. Tetapkan parameter farmakoterapi • Karakteristik obat • Efikasi terapi dan efek merugikan dari regimen • Perubahan fisiologik pasien • Efisiensi pemeriksaan laboratorium • Kepraktisan pemantauan • Ketersediaan • Biaya pemantauan. b. Tetapkan sasaran terapi (end point) c. Tetapkan frekuensi pemantauan d. Lakukan pemantauan terapi dengan metode SOAP (<i>Subjectif-Objectif-Assesment-Plan</i>) dan dicatat direkam medis. • S (<i>Subjectif</i>) : semua keluhan pasien terkait penggunaan obat yang dirasakan pasien. Contoh : Pasien mengatakan demam, nyeri. • (<i>Objectif</i>) : keadaan umum pasien, hasil pemeriksaan yang dapat di ukur. Contoh : k/u cukup, suhu badan, tekanan darah, kadar gula darah. • A (<i>Assesment</i>) : penilaian penggunaan obat pasien / identifikasi masalah terkait obat; riwayat alergi pasien; interaksi obat. Contoh : Pasien mendapatkan parasetamol, pasien sudah tidak demam/nyeri dan suhu badan 36°C, ada obat tidak ada indikasi. • P (<i>Plan</i>) : Rekomendasi yang diberikan berhubungan dengan assesment yang dilakukan. Contoh : Menghentikan pemberian parasetamol atau parasetamol diberikan bila demam/nyeri saja. • Sasaran : Target edukasi pengobatan yang telah dijelaskan Contoh : Pasien patuh minum obat dan keluarga pasien paham pengobatan pasien. 6. Lakukan tindak lanjut dengan langkah - langkah: a. Komunikasi efektif dengan tenaga kesehatan lain b. Lakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada pasien atau keluarga pasien		
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi RS (Apoteker)		